



Lactancia Materna



La OMS recomienda lactancia materna exclusiva (es decir sin otros alimentos, agua o jugos) hasta los 6 meses de edad, y lactancia materna complementada con otros alimentos hasta al menos los 2 años como la forma más saludable y nutritiva de alimentar a su hijo(a).

El presente manual tiene por objetivo entregarles a las madres primerizas conocimientos básicos para una adecuada técnica de lactancia materna y una actualización en los conocimientos a las madres que ya han tenido experiencia en lactancia materna.

INTRODUCCIÓN

La leche materna constituye el método de alimentación que abarca todo los requerimientos nutricionales, inmunológicos, emocionales y de crecimiento del recién nacido.

A nivel internacional, Chile alcanza una prevalencia de lactancia materna exclusiva (LME) de un 56.3% hasta los 6 meses o más. En cuanto a factores posteriores al parto y su posible relación con la lactancia materna exclusiva por 6 meses o más, se demostró que un 56,2% de las mujeres que recibieron orientación en temas como el acople al pecho y/o técnicas de lactancia lograban exitosamente la LME. (Rosso, F, y otros, 2013, pp. 15-22). Junto a esto, se ha demostrado que con la promulgación de la ley que implementó la extensión del permiso postnatal parenteral ha aumentado la tendencia a una extensión de la lactancia materna. (Guerra, X., Caro, P. 2018. Rev. Ch. pediatría).

Este manual ha sido realizado con el fin de orientar, capacitar y educar a las mujeres que están gestando y pretende ser una actualización a la base de sus conocimientos.

Este texto está basado en los contenidos del Manual de Lactancia materna (LM) que otorga el Ministerio de Salud (MINSAL) y en las cartillas educativas que entrega el programa Chile Crece Contigo como Protección integral a la infancia junto a otros estudios que se detallan en la bibliografía.

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA

Beneficios para la Madre

Disminución del sangrado post parto

Facilita la recuperación del peso pre gestacional

Disminuye el riesgo de Cáncer de mama y ovario (demostrado por al menos un año de LM acumulada).

Disminuye el riesgo de depresión post parto

Favorece la economía familiar

Favorece el apego, vínculo madre-hijo

Beneficios para el niño/a

Protege al recién nacido en enfermedades infectocontagiosas (gastrointestinales y respiratorias).

Menor prevalencia de obesidad

Disminuye el riesgo de presentar caries

Disminuye el riesgo de tener diarrea

Mejor desarrollo psicomotor y cognitivo

Menor riesgo de mala oclusión dental

¿QUÉ ES Y CÓMO SE PRODUCE LA LECHE MATERNA?

La leche materna es un fluido vivo y cambiante que se adapta a los requerimientos nutricionales e inmunológicos del niño(a). Modifica su composición a medida que el niño(a) va creciendo y necesita otros nutrientes y factores de protección. La leche materna tiene variaciones a las distintas horas del día, entre cada mamada o en una misma mamada.

La grasa en la leche materna tiene fluctuaciones diurnas, con más concentración después de mediodía. También hay importante variación dentro de una misma mamada, siendo la segunda leche 4 a 5 veces más concentrada en grasa que la primera. Cuando la madre se extrae la leche, debe tener en cuenta esta diferencia, especialmente en el caso de prematuros, ya que la leche del final tiene más calorías. Después del nacimiento, el principal aporte de energía en el niño(a) lo constituyen las grasas. **La leche materna proporciona el 40% de las calorías en forma de grasa**

Calostro



Líquido transparente amarillento, se produce en el embarazo hasta el 3er día de vida. Coloniza su intestino y previene enfermedades. Se potencia con la primera mamada en el contacto piel-piel dentro de la primera hora de nacimiento. 5-7 ml por toma.

Leche de Transición



Aspecto cremoso-amarillento que se produce entre el cuarto y decimoquinto día post parto.

Leche Madura



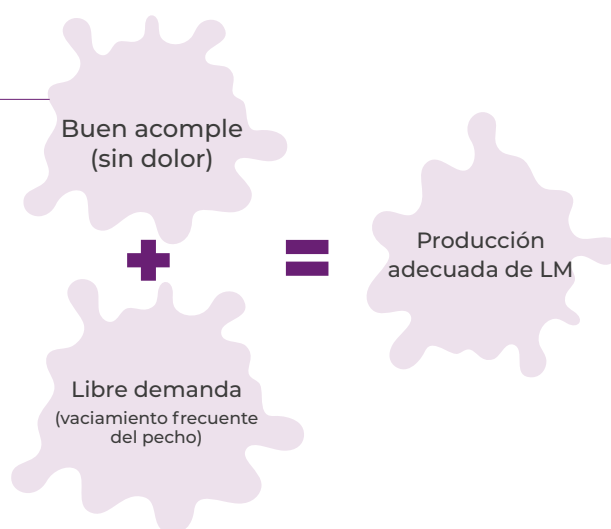
Se produce desde los 15 días post parto y su volumen alcanza 700 -900ml/día los primeros 6 meses. De color amarillenta o azulosa. Abundante en agua (88%), lípidos, proteínas e hidratos de carbono.

La leche es producida y excretada gracias a la acción de dos hormonas:

- **Prolactina:** produce la leche en una mayor concentración en la noche (se recomienda amamantamiento nocturno)
- **Oxitocina:** secreta la leche a los conductos mamarios, esta última se inhibe con el dolor y el estrés.

En el último trimestre del embarazo los niveles plasmáticos de prolactina están muy elevados, pero su acción productora de leche permanece bloqueada hasta el momento del alumbramiento en que las hormonas placentarias caen bruscamente. El nivel plasmático de prolactina se eleva como respuesta a la succión del pezón durante el amamantamiento.

Para que se mantengan niveles elevados de prolactina, se recomienda amamantar a libre demanda con un óptimo acople y que se facilite el vaciamiento efectivo de la mama. Amamantar al menos 7 veces en el día y mínimo una vez durante la noche.



La producción de leche mediada por la prolactina, ocurre en **un proceso llamado “lactogénesis”** que se desarrolla en tres etapas:

ETAPA 1

Se inicia la capacidad secretora glandular de la mama a las 20 semanas hasta los primeros días de vida del recién nacido (calostro).

ETAPA 2

Se inicia la actividad secretora con producción de leche (bajada de la leche) entre el 2do y 5to día post parto.

ETAPA 3

Galactopoyesis o mantención de la producción de leche. Esta etapa depende del nivel de hormonas como de la extracción de leche.

¿QUÉ ES LA LIBRE DEMANDA?

Es poner al pecho a tu hijo(a) siempre que creas que tiene hambre, cada vez que quiera y por el tiempo que desee. Responde al respeto de las necesidades del niño(a) apoyando el desarrollo de una personalidad segura que permitirá en el futuro su independencia. Además, es una respuesta sensible que fortalece el vínculo.

Signos tempranos de que el niño(a) quiere amamantar:

Abre la boca

Busca el pecho

Chupa sus manitos

Comienza a enojarse

Llora

ES IMPORTANTE QUE EN LOS PRIMEROS DÍAS DE VIDA DEL NIÑO(A) SE APRENDA A RECONOCER SUS ESTADOS DE ÁNIMO, ES COMENZAR A CONOCERSE ENTRE LOS DOS. SI ESTÁ IRRITADO O ENOJADO Y LLORANDO, LO PRIMERO QUE DEBE HACER ES CALMARLO Y LUEGO PONERLO AL PECHO.

LA HORA SAGRADA

La “hora sagrada” hace referencia a la primera hora de vida del recién nacido, un tiempo ininterrumpido de contacto piel con piel del torso desnudo de la madre con el niño(a). En ese momento ocurren comportamientos observables que conducen a la primera toma de leche materna. La OMS recomienda vivir esta hora (en recién nacidos sin complicaciones) para promover la lactancia materna ya que esto contribuye a que la lactancia dure más, se regule el estrés del bebé y la ansiedad materna.



AMAMANTAMIENTO

La boca del niño(a) y la mama de la madre forman una perfecta “unidad de succión” que trabajan en forma sincronizada y armónica extrayendo la leche y permitiendo que el niño(a) la degluta sin atragantarse. La formación embriológica temprana de las estructuras bucales permite que el niño(a) ejercite la succión y la deglución mucho antes de nacer. Por lo tanto, el niño(a) prematuro también es capaz de succionar, aunque no con la organización, fuerza y avidez que lo hace el niño(a) de término.

Después del parto, se intensifican en el niño(a) los reflejos de búsqueda del pezón y de succión, y en la madre se desencadena por acción de la oxitocina, la expulsión de la placenta, contracción de las paredes uterinas, protrusión (sobresale) del pezón y el cono areolar para facilitar el acoplamiento de la boca del niño(a) en la primera mamada.

El niño(a) de término tiene destrezas neuro-sensoriales y motoras suficientes para reconocer el olor de su madre, pues el pezón secreta una sustancia odorífera que estaba en el líquido amniótico y que el niño(a) reconoce; visualizar la areola y se acopla para succionar vigorosa y armónicamente.

CORRECTO ACOUPLE

El acople se genera mediante el reflejo de búsqueda del lactante y la mama de la madre.

¿Cómo lograr un acople correcto?

1. Madre y niño(a), independiente de la postura que se adopte, deberán estar cómodos y muy juntos.

2. El niño(a) con el cuerpo alineado a su madre.

3. El niño(a) va al pecho, NO el pecho al niño. Tomar al niño/a con la palma apoyada en la nuca. Antes de abrir la boca doblar o girar el cuello, el pezón debe estar frente a la nariz.

4. Estimular al niño(a) que abra la boca con la punta del pezón, moviéndolo de nariz a boca.

5. Cuando abra la boca, acercar al niño(a) suavemente al pecho.

6. Los labios del niño(a) deben quedar evertidos (dados vuelta) como una boca de pez.

7. El mentón puede quedar pegado al pecho y la nariz tocando el pecho o liberada.

8. La areola se debe ver lo menos posible, sobre todo por el lado del mentón del niño(a).

No se recomienda presionar el pecho con los dedos en forma de “pinza” ya que con esta maniobra se estira el pezón y se impide al niño(a) acercarse lo suficiente para mantener el pecho dentro de su boca.

SIGNOS DE BUEN ACOUPLE

Mentón y nariz cerca del pecho

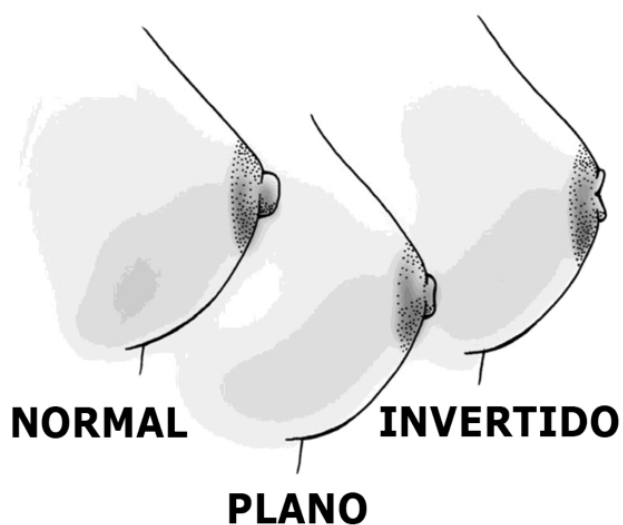
Labios evertidos

Boca del bebe bien abierta

Se observa más la areola por encima de la boca que por abajo

No hay dolor

TIPOS DE PEZONES



En el caso de pezones planos o invertidos no deberían ser un problema para la lactancia, pues los lactantes maman del pecho no del pezón. Durante el abrazo NO se deben preparar los pezones, se debe confiar en la capacidad materna de alimentar a su hijo(a).

En la mayoría de los casos, no es necesario el uso de pezonera, sin embargo, puede ser una solución temporal si no se consigue el acople al pecho.

NO ofrecer chupete ni mamaderas hasta tener una lactancia materna instalada.

Pezoneras



POSICIONES PARA AMAMANTAR

Podemos encontrar muchas posiciones para amamantar, la que se escoja depende de la comodidad de la madre y del recién nacido, así como de las circunstancias del día a día.

La mejor recomendación es que la madre esté cómoda con espalda, brazos y pies apoyados para evitar dolor. El niño(a) se debe llevar al pecho, no el pecho al él.

A continuación, se muestran las posiciones más conocidas para que la diada decida cual utilizar.



Posición sentada con niño/a en reversa: se recomienda como primer acople ya que permite un correcto control de la cabeza.



Posición sentada con niño acunado: el niño(a) de posición horizontal es la más común en contacto piel con piel.



Posición sentada con niño vertical (caballito): el niño(a) sentado sobre la pierna de la mamá. Se recomienda cuando la madre tiene un reflejo eyectolácteo exagerado (sale mucha leche), niños con fisura labiopalatina, mamas muy grandes y cuando los niños se duermen al mamar. Se ubica la mano en forma de "C" en el pecho para ofrecerlo y la mano libre sostener la cabeza por detrás de las orejas.



Posición de canasto o Rugby: se ubica al niño(a) debajo del brazo del lado que va a amamantar, con el cuerpo rodeando la cintura de la madre. La madre maneja la cabeza del niño(a) con la mano del lado que amamanta, tomándolo por la base de la nuca. Útil en obstrucción de conductos, mastitis, cesárea (para no comprimir la herida) y gemelos en forma simultánea.

POSICIONES PARA AMAMANTAR



Posición acostada con niño(a) acostado: ambos en paralelo. Se recomienda para amamantar durante la noche y para madres en recuperación post parto.



Posición acostada con niño/a sobre la madre (decúbito ventral): la madre acostada de espalda y el niño(a) recostado sobre ella entre ambos pechos; se debe permitir que el niño(a) cabeccee, busque y escoja de cual mamar. Se recomienda cuando el niño(a) acaba de nacer, puede demorar entre 10 a 60 min en encontrar el pecho y lograr el acople.

¿CÓMO PUEDO SABER SI MI HIJO/A TOMA BIEN PECHO?

- Amamanta 8-12 veces en 24 horas.
- La deglución se escucha rítmica mientras toma pecho.
- Posición y acople sin dolor.
- Los pechos están blandos después de amamantar.
- La cantidad mínima de pañales mojados al día es proporcional a los días de vida, es decir al primer día 1 pañal mojado, al segundo día dos pañales. A partir del 6to día debe mojar 6 pañales.
- Depositiones los primeros tres días de color marrón o verde oscuro y viscosas. **Meconio.**
- Depositiones entre el 3-4 día color verde grisáceo. **Transición.**
- Una vez que ocurre la bajada de leche las depositiones son amarillas, blandas y con grumos. Alrededor de 2 en 24 horas o una post lactancia.

Es normal en algunos niños presentar **“Crisis de Lactancia”**, son entre 3 a 5 días en distintos periodos de tiempo que el niño pide mamar más de lo normal, suele ocurrir en periodos de rápido crecimiento.

Son frecuentes:

3-6 sem de vida

3 meses

1 año

Las crisis son transitorias mientras el niño(a) suba bien de peso y moje pañales. Una vez que esté instalada la lactancia y la diada mamá-hijo(a) tenga su ritmo, la madre podrá reconocer sus señales y adaptarse a los requerimientos. **Se debe tener en consideración que la libre demanda es sagrada para la producción de leche y no hay leches malas ni insuficientes; se debe usar una buena técnica o buscar ayuda con asesoras de lactancia para buscar la mejor manera de darle lactancia materna a su hijo(a).**

COMPLICACIONES EN LA LACTANCIA

Amamantar NO debe producir dolor, si esto ocurre es probable que su hijo(a) no esté amamantando correctamente. Se recomienda buscar la causa de la complicación, evaluando la mama, la boca del recién nacido y el acople. Es recomendable de todas maneras consultar a un profesional de salud.

Aquí se presentan las complicaciones más comunes:

COMPLICACIONES

Grietas superficiales: se produce por mal acople, presión o tracción exagerada con la lengua.



Grietas profundas: son aquellas que una vez corregida la técnica de lactancia aún producen dolor y no sanan. Las grietas profundas aumentan la probabilidad de ingreso de bacterias al interior de la mama.



Obstrucción mamaria: retención de leche dentro del tejido glandular mamario. Se observa como un bulto en la mama del porte de una almendra o de una nuez. Puede producirse por compresión externa, mal posición al amamantar o al dormir, sostén apretado, obstrucción interna de la mama.



MANEJO

- Corregir postura y posición de amamantamiento.
- Vaciamiento frecuente de la mama.
- Comenzar a amantar por el lado menos afectado.
- Estimular reflejo de eyección antes de comenzar a amamantar.
- Extracción manual si la mama está tensa.
- Evitar uso de discos absorbentes ya que aumentan humedad y carga bacteriana, esto impide la cicatrización.
- Usar posiciones que permita control de la cabeza del lactante.
- Lubricar pezón con leche materna

- Evaluación por Clínica de lactancia.
- Extracción de leche cada 2-3hrs
- Idealmente no usar sostén para que las grietas sequen lo antes posible, de lo contrario uso de sostén de algodón, tomar sol de forma indirecta, dejar pechos al aire, ampolleta roja a 1mt de distancia en caso de que no haya sol
- Lavar con abundante agua y secar con secador aire frío.
- No usar cremas como lanolina, sólo poner leche materna sobre el pezón y dejar que seque.

- Aplicar frío para disminuir la inflamación post amamantamiento (puede usar hojas de repollo frío).
- Calor local durante el amamantamiento.
- Vaciamiento frecuente de la mama
- Masajear la zona afectada con movimientos circulares con el pulgar y después desplazar el dedo hasta el pezón. "Dibujar un 9".
- Niño debe mamar con la barbilla dirigida a la zona obstruida.

COMPLICACIONES

Mastitis: área del pecho que está sensible, caliente e hinchada. Asociado a fiebre de 38,5° o más alta, escalofríos, dolor similar al de la gripe. **Causas:** Alimentación poco frecuente, succión ineficaz del niño, grietas del pezón, demasiada cantidad de leche, presión en el pecho, estrés materno y fatiga.



Absceso mamario: se produce como consecuencia de una mastitis tratada inadecuadamente o tardía. Se forma una colección purulenta en el tejido mamario.



Congestión mamaria primaria: ocurre retención de leche dentro del tejido glandular mamario. La causa es la bajada de leche y se ven mamas aumentadas de tamaño, duras y sensibles.

Congestión mamaria secundaria: ocurre por vaciamiento inadecuado o poco frecuente o por un reflejo de eyección inhibido. Se ven mamas duras, dolorosas, calientes y a veces enrojecidas. Desaparece en 2-3 días.

Perla de leche: puede ser por tracción o mal acople o por infección microbiana.



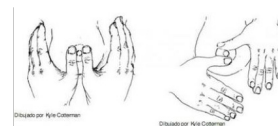
MANEJO

- **NO** dejar de amamantar.
- Remoción eficaz de leche, comenzando por la mama afectada.
- Reposo en cama.
- Uso de analgésicos o antiinflamatorios.
- Uso de compresas frías en las mamas.
- Poner al niño al pecho con la quijada o la nariz hacia el bloqueo para ayudar a drenar el área.
- Masajear el pecho durante la alimentación.
- Si los síntomas de mastitis son leves y han estado menos de 24hrs el manejo conservador puede ser suficiente.
- Si los síntomas no mejoran se debe comenzar a usar antibióticos con indicación médica.

- La mayoría de los casos tiene manejo quirúrgico y uso de antibióticos.

- Vaciamiento efectivo y frecuente.
- Revisar técnica de lactancia.

- Calor local
- Extracción frecuente
- Usar técnica de presión inversa: aplicar presión sobre un radio de dos a cuatro cm de areola en la zona que rodea la base del pezón, con el objeto de desplazar ligeramente la hinchazón hacia atrás y hacia el interior del pecho.



- Consultar a profesional de salud

RECOMENDACIONES PARA UNA LACTANCIA MATERNA EXITOSA

- Se debe dar a libre demanda, no imponer horarios.
- Asegurarse que el niño/a tome 8-12 veces en 24 horas.
- No ofrecer fórmulas de inicio ni ningún otro líquido.
- Madre sentada en postura cómoda, apoyando espalda y hombros relajados.
- Estimular el reflejo de búsqueda del niño, acercando suavemente la boca al pezón.
- Acudir a consulta si hay dudas con lactancia y técnica.
- No dar chupetes ni mamaderas hasta tener una lactancia materna instalada.

EXTRACCIÓN DE LECHE

La extracción de leche se puede usar ya sea para almacenar leche, mantener producción, alimentar a recién nacido prematuro o extraer y desechar en caso de uso de fármacos. La extracción puede ser manual o con extractor de leche. Para ambos tipos de extracción se debe considerar:

- ✓ Lavado de manos previo.
- ✓ Masajes en las mamas, circular o en peineta hacia el pezón.
- ✓ Uso de paño caliente tolerable.
- ✓ Lugar tranquilo y mínimo 20 min.
- ✓ Tener pensamientos gratos del niño, tener una foto o alguna prenda de ropa con su aroma.
- ✓ Asegurarse que el tamaño del embudo del extractor sea adecuado para el tamaño del pezón.
- ✓ Debe ser usado el extractor a una potencia que no cause dolor a la madre.



EXTRACCIÓN MANUAL DE LECHE (según la técnica de Marmet)

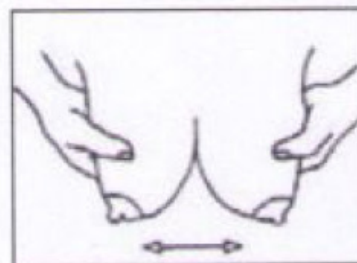
FASE 1. MASAJE



1. Masajea



2. Frota



3. Sacude

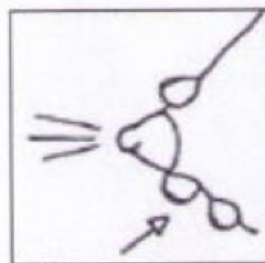
FASE 2. EXTRACCIÓN



1. Coloca



2. Comprime

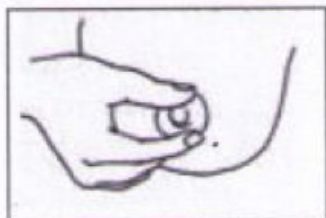


3. Ordeño
en dirección al
pezón sin deslizar
los dedos



4. Repite

ACCIONES



No exprimas



No deslices



No estires

EXTRACCIÓN MECÁNICA O ELÉCTRICA

- Hacer masajes en la mama, uso de paños calientes antes de comenzar.
- Poner el embudo en la mama y sostener desde el embudo, NO de la botella.
- Primero estimular y luego extraer.

Fase de ESTIMULACIÓN: ritmo rápido de extracción para simular el reflejo de eyección de la leche e iniciar el flujo de leche. La fase de estimulación tiene el doble de velocidad que la fase de extracción.

Fase de EXTRACCIÓN: ritmo de extracción más lento para extraer la leche suave y eficazmente.



LA LIMPIEZA DEL EXTRACTOR

- Debe ser con agua potable (corriente de la llave) y detergente para loza.
- No utilice escobillas muy rígidas ya que pueden dañar las partes delicadas como las piezas de silicona. Si utiliza una escobilla, debe ser destinada sólo para este uso.
- Debe procurar un buen enjuague que no deje residuos jabonosos.
- Las piezas que no son lavables es recomendable limpiarlas con un algodón empapado en Alcohol de 70°.
- Es importante no guardar las piezas del extractor hasta que estén completamente secas, para evitar el crecimiento de bacterias y gérmenes. Es recomendable que las piezas se pueden colocar sobre un paño o toalla de papel en una superficie limpia y esperar a que se sequen solos.
- En caso de **esterilización** se puede usar bolsas esterilizadoras que venden en el comercio o hervir los utensilios en una olla con agua que los cubra, durante 5-10 minutos.
- **Los extractores son de uso personal, no se deben compartir y evitar el uso de segunda mano.**

¿CÓMO AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE LECHE?

Extracción poderosa o Power Pumping

Consiste en **hiperestimular el pecho con extractor cada hora o cada 45 minutos durante al menos 24 horas** y dejando un descanso nocturno no superior a las cuatro horas. Lo normal es que en las primeras extracciones los resultados sean nulos o mínimos. Por lo general, se obtiene un volumen aceptable de leche materna antes de que hayan transcurrido 48 horas desde el inicio del proceso. Las cantidades suelen doblarse de un día para otro.

La hiperestimulación o extracción poderosa con sacaleches produce frecuentes peaks de prolactina que disparan la eficacia de las glándulas mamarias y aumentan rápidamente la producción de leche materna. Por ello siempre es más eficaz sacarse leche con mucha frecuencia, poco rato cada vez, que extraerse leche durante mucho rato y pocas veces en total.

CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA

La leche humana almacenada mantiene sus cualidades únicas al grado de que sigue siendo el estándar de oro en alimentación infantil, muy superior a la fórmula artificial.

RECOMENDACIONES

- Refrigerar la leche en la primera bandeja del refrigerador. Nunca en la puerta por las variaciones de temperatura.
- La leche que no vaya a ser usada se debe congelar lo más pronto posible, entre 50-100cc, en pequeñas cantidades para luego descongelar sólo lo que el lactante tomará.
- Etiquetar con fecha de extracción antes de conservar para comenzar a usar siempre la más antigua.
- Usar bolsas de almacenamiento que son exclusivas para estos casos, o contenedores de vidrio limpios con tapa.
- Una vez descongelada no se debe volver a congelar por el riesgo de crecimiento bacteriano. Se debe usar dentro de 24 horas.
- Para transportar la leche debe usar cooler o bolso térmico con unidades refrigerantes.
- No transportar la leche congelada.
- **Para descongelar** se recomienda hacerlo paulatinamente, es decir, el día anterior moverla del freezer al refrigerador. De lo contrario, calentar agua y poner la mamadera con leche dentro de un recipiente con el agua caliente, de la misma forma que para calentar la leche, luego homogeneizar.
- **NO** se recomienda calentar la leche a fuego directo ya que se destruyen componentes vivos de la leche.
- Para dar esta leche conservada en mamadera, se recomienda que el lactante tenga la lactancia instalada. Se debe usar mamadera con chupete ancho de recién nacido para simular el pecho y entregar un menor flujo de leche.

DURACIÓN DE LA LECHE EXTRAÍDA

LUGAR	TEMPERATURA	DURACIÓN
Mesón	Ambiente hasta 25°C	6-8 horas
Cooler con unidades refrigerantes, abrir lo menos posible.	-15° a 4° C	24 horas
Refrigerador (1era bandeja)	4°	5 días
Freezer (guardar al fondo)		
Refrigerador 1 Puerta	-15°	2 semanas
Refrigerador 2 Puertas	-18°	3-6 meses
Congelador vertical-horizontal	-20°	6-12 meses

ROL DEL PADRE EN LA LACTANCIA

El padre tiene un rol esencial para entregar apoyo y compañía en la crianza activa del niño(a).

El padre aporta estímulos sensoriales, cognitivos y afectivos que son complementarios o diferentes a los que entrega la madre, por lo tanto, su papel es profundamente importante en el desarrollo psicomotor y social del niño(a).

Cuando el niño(a) tiene la visión de ambos padres puede desarrollar una imagen más completa de sí, reflejando diferentes facetas de su personalidad.

La relación de pareja puede enriquecerse de sobremano cuando el padre se siente involucrado en las atenciones del menor. Idealmente él debe participar en los cuidados y manifestaciones de afecto y alegría para el niño(a). De esta forma contribuirá a que los cambios que sufre la mujer durante el periodo de gestación-lactancia sean más fáciles de sobrellevar, fortaleciendo la relación de pareja, pues ayuda a que la madre se sienta más tranquila, generando un ambiente cálido y emocionalmente adecuado lo cual favorece el crecimiento y bienestar del recién nacido.

Es importante también que ambos adultos descansen cuando el niño(a) lo haga, para así tener las energías suficientes para atender y consolar cuando lo requiera. Recuerde también que contener y calmar el llanto de su hijo(a) es una tarea compartida, tanto de día como de noche.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Strain, H., Orchard, F., Fuentealba, L., y cols. (2017). Acompañando tu Lactancia, Manual operativo de Lactancia Materna. Chile Crece Contigo, Ministerio de Salud de Chile.
2. Márquez Doren, F., Lucchini Raies, C., (2018) Enfoques para apoyar la Lactancia Materna, una invitación a su integración. Revista Horizonte Enfermería. (3era ed.) Chile. (p. 1-4)
3. Rosso F, Skarmeta N, Sade A. (2013) Informe técnico: Encuesta nacional de la lactancia materna en la atención primaria ENALMA. Chile [Internet]. (p.7.).
4. Lucchini Raies C, Márqu Strain, H., Orchard, F., Fuentealba, L., y cols. (2017). Acompañando tu Lactancia.
5. Manual operativo de Lactancia Materna. Chile Crece Contigo, Ministerio de Salud de Chile.
6. Márquez Doren, F., Lucchini Raies, C. (2018) Enfoques para apoyar la Lactancia Materna, una invitación a su integración. Revista Horizonte Enfermería. (3era ed.) Chile. (p. 1-4)
7. Doren F, Rivera Martínez M. (2017)"Yo quiero amamantar a mi hijo": Develando la experiencia de mujeres que enfrentaron dificultades en su proceso de lactancia. Revista Chilena Pediatría. (p 626).
8. Pérez R., Prieto D. (2017) Consejos para una Lactancia Materna exitosa. Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, México. (p 8-11).
9. Brahm, P., Valdés, V. (2017) Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar. Revista chilena de pediatría, (88 ed.) Chile. (p07-14).

Manual elaborado por Área Materno Neonatal
Hospital y Clínica UC
Red de Salud UC CHRISTUS
Revisado por Unidad Técnica de Educación
Versión 1- 2021